

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA**

**TENTANG
PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN**

**No.: 024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
No.: 338/DPM/E-PKS/DIR/XI/2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat (06/11/2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

1. **PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Menara Batavia, Lantai 27, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang dalam hal ini diwakili oleh **Armon Trifery** dan **Suharjo P. Lumbanraja**, dalam kedudukannya masing-masing sebagai **Direktur** oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
2. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai **Direktur Utama PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta No.26/28 November 2009 dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009/31 Desember 2009, serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Disa Prima Medika No.10/16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai Direktur RS Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan izin operasional Rumah Sakit No. 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS, sebagai Direktur RS Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan.
(untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
PENGERTIAN**

1. **Peserta atau Tertanggung** adalah karyawan dan atau dengan keluarganya yang mempunyai hubungan kerja dengan suatu perusahaan dan tercatat sebagai Peserta program asuransi **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rawat Jalan Dokter Umum** adalah semua pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi atau pada rumah sakit atau Klinik dengan atau tanpa obat dan tidak sedang menjalani rawat inap.

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika	Hal. 1/22	Paraf	Pihak I  Pihak II 
--	-----------	-------	---

THE
 THE
 THE

THE
 THE

THE
 THE

THE
 THE

THE
 THE
 THE

THE
 THE
 THE

THE
 THE

THE
 THE

THE

THE
 THE

THE
 THE

THE

THE
 THE

THE
 THE
 THE

3. **Rawat Jalan Spesialis** adalah semua pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis/ahli di rumah sakit atau Klinik.
4. **Rawat Inap** adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit dimana pasien menginap sedikitnya 1 (satu) malam berdasarkan rekomendasi dari dokter dan atau dari rumah sakit lain, atau keadaan emergensi.
5. **Ruang Isolasi** adalah ruang perawatan untuk pasien dengan penularan penyakit, untuk Peserta yang memerlukan kamar isolasi sesuai dengan indikasi medis.
6. **Operasi** adalah tindakan medis spesialis dengan menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa tenaga anestesi pada suatu ruangan tertentu.
7. **Perawatan Khusus** adalah perawatan yang membutuhkan ruangan perawatan, tindakan, obat-obatan dan tenaga ahli, dan memerlukan pemeriksaan lebih intensif, misalnya perawatan di ICU, ICCU, HCU, PICU, Unit luka bakar, Unit Perinatology.
8. **One Day Care** adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan atau tanpa anestesi dimana Peserta dapat langsung pulang tanpa harus melaksanakan rawat inap (merupakan paket yang terdiri dari tindakan dokter, anestesi dan obat, serta sewa kamar).
9. **Penyakit** adalah kondisi fisik seseorang yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat.
10. **Rujukan** adalah surat pengantar yang diberikan oleh dokter untuk pemeriksaan/pengobatan lebih lanjut dan atau rawat inap di rumah sakit.
11. **Emergensi** adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi Peserta (dibuktikan dengan data resep obat yang diberikan oleh dokter yang merawat).
12. **Harga Netto Apotik atau "HNA"** adalah Harga dasar obat yang ditetapkan oleh distributor dan menjadi acuan bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan **Harga Jual Apotik** atas obat-obatan yang dipergunakan Peserta.
13. **Network Provider** adalah jaringan pelaksana pelayanan kesehatan yang mempunyai ikatan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
14. **Non Network Provider** adalah jaringan pelayanan kesehatan yang tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
15. **Tenaga Medis** adalah seseorang yang telah melaksanakan pendidikan formal dibidang kesehatan untuk mempraktekan bidang ilmunya kepada masyarakat, misalnya : dokter, perawat, dll. Tenaga medis harus memiliki izin profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. **Kartu Peserta** adalah Kartu Peserta Program Kesehatan yang diberikan kepada setiap Peserta asuransi (pegawai dan keluarganya yang ditanggung) baik dalam bentuk fisik maupun elektronik (*E-Card*), sebagai identitas diri Kepesertaan pada Program Kesehatan ini dan juga sebagai bukti untuk bisa menggunakan fasilitas Jaringan Rekanan (Lampiran 2).
17. **Perlu Secara Medis** adalah pelayanan medis yang sesuai dengan diagnosa dan merupakan pengobatan yang biasa dilakukan terhadap penyakit yang dijamin dan sesuai dengan standar pelayanan medis (SPM IDI), bukan untuk kepentingan Dokter atau Pemegang Polis dan bukan atas permintaan Pemegang Polis dimana biaya yang

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika	Hal. 2/22	Paraf	Pihak I <i>[Signature]</i> Pihak II <i>[Signature]</i>
--	-----------	-------	---

dikenakan masuk akal dan sesuai dengan penyakit.

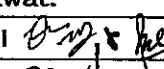
18. **Pengecualian** adalah pelayanan kesehatan/tindakan yang tidak dijamin oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Pelayanan perawatan kesehatan dan/atau pengobatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada karyawan dan atau Peserta **PIHAK PERTAMA** mencakup :
 - a. Rawat Jalan Umum
 - b. Rawat Jalan Spesialis
 - c. Rawat Jalan Gigi ; *Konsultasi, Penambalan, Extraksi Gigi (non Impacted), Perawatan syaraf gigi, dan Pembersihan Karang gigi.*
 - d. Rawat Inap, dengan atau tanpa pembedahan
 - e. Pemeriksaan Penunjang Medis
 - f. Tindakan Medis
 - g. Emergensi
 - h. Obat-obatan
 - i. Persalinan
 - j. One day care
2. Bekerja sama dengan
 - AdMedika : **YA / TIDAK** (*Coret yang tidak perlu*).
 - Isomedik : **YA / TIDAK** (*Coret yang tidak perlu*).
3. Pelayanan edukasi kesehatan dan atau sosialisasi hidup sehat yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada karyawan dan atau Peserta **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk partisipasi sebagai pembicara (nara sumber), dokter/perawat tamu sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun pada kegiatan Seminar/Health Talk/Bakti Sosial yang dilaksanakan oleh Perusahaan rekanan **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan Peserta **PIHAK PERTAMA** dengan dikonfirmasi dahulu kepada **PIHAK KEDUA** melalui telepon/surat permintaan yang dikirimkan melalui email selambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya.
4. Tambahan dan/atau pembatasan atas suatu Layanan Kesehatan dalam kasus tertentu akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dan dilampirkan sebagai tambahan dalam perjanjian ini.
5. **Pengecualian** atas Layanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** bagi Peserta, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b) Menolak pembayaran biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang tidak Perlu Secara Medis, atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini .
 - c) Menerima konfirmasi perubahan Tarif, apabila terjadi perubahan tarif dari **PIHAK KEDUA**.
 - d) Melakukan pengawasan (monitoring) terhadap Peserta yang sedang menjalani perawatan untuk mengetahui status perkembangan kondisi Peserta dengan menghubungi Ruang Perawatan dimana Peserta **PIHAK PERTAMA** dirawat.

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika	Hal. 3/22	Paraf	Pihak I  Pihak II 
--	-----------	-------	---



- e) Apabila **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan yang dikecualikan oleh **PIHAK PERTAMA** seperti yang disebutkan dalam pasal 5 dan lampiran pengecualian Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak melunasi semua tagihan yang dikecualikan tersebut.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a) Menerbitkan Kartu Peserta atau Bukti Diri lain yang akan dipergunakan oleh setiap Peserta untuk membuktikan identitas dan berlakunya Kepesertaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Membayar tagihan biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atas diri Peserta, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- c) Memberikan konfirmasi Kepesertaan untuk kasus **Rawat Inap** atas diri Peserta dan menerbitkan **Surat Jaminan Rawat Inap** kepada **PIHAK KEDUA**.
- d) Memberikan Sosialisasi Prosedur Pelayanan Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- e) Menjaga Integritas dengan tidak membuat dokumen palsu untuk digunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan dokumen palsu tersebut.
- f) Berdasarkan **Pasal 5** jika **PIHAK PERTAMA** mendapatkan bukti **otentik** secara sah maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak membayarkan transaksi tersebut.

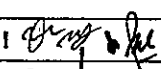
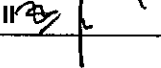
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **Hak PIHAK KEDUA:**

- a) Menerima pembayaran tagihan biaya-biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a) Bertanggung jawab atas pengadaan/penyediaan semua Fasilitas pelayanan kesehatan kepada Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** baik yang bersifat Fasilitas Medis maupun Administratif.
- b) Segala bentuk pemberhentian layanan yang diakibatkan oleh alasan apapun, wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**. Dan akan berlaku efektif setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c) Memeriksa masa berlakunya Kartu Peserta serta keabsahannya.
- d) Memberikan Pelayanan Kesehatan yang memerlukan pelayanan medis kepada Peserta **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan prosedur dan tidak menyimpang dari kode etik pemberian layanan kesehatan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- e) Bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang dialami Peserta dan atau tuntutan yang mungkin timbul karena kerugian tersebut yang disebabkan oleh adanya kelalaian, kesalahan dan/atau pelanggaran yang sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan dalam melakukan pemeriksaan, pengobatan, pemberian indikasi medis, pemberian tindakan medis, atau kesalahan administratif dengan mengkonfirmasi dulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika	Hal. 4/22	Paraf	Pihak I  Pihak II 
--	-----------	-------	---

- f) Wajib Menerbitkan dan menyerahkan hardcopy dan softcopy *Buku Tarif (dalam bentuk excel)* kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai acuan dalam menentukan jumlah klaim yang ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- g) Tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta **PIHAK PERTAMA**, pelayanan berlaku sama seperti pasien biasa.
- h) Menghubungi **PIHAK PERTAMA** untuk konfirmasi indikasi perawatan atas diri Peserta yang **Perlu Secara Medis** untuk di **Rawat Inap**, guna memperoleh **Surat Jaminan Awal Rawat Inap**.
- i) Menginformasikan secara jelas kepada **PIHAK PERTAMA**, pada saat **PIHAK PERTAMA** membutuhkan informasi-informasi sebagai berikut :
- Kondisi Peserta saat ini
 - Diagnosa
 - Nama Dokter yang merawat
 - Perkiraan biaya yang sudah terjadi
- j) Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait perkembangan kondisi medis Peserta selama dilakukan perawatan.
- k) Menghubungi **PIHAK PERTAMA** segera setelah Peserta diperbolehkan pulang oleh Dokter yang merawat dan mempersiapkan serta mengirimkan seluruh dokumen yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** untuk menerbitkan **Surat Jaminan Akhir Rawat Inap**, yaitu :
- Form Informasi Medis Awal dan Hasil Lab. Rujukan Rawat Inap
 - Surat Pernyataan Rawat Inap
 - Surat Pernyataan Naik Kelas (jika permintaan sendiri)
 - Rekap Tagihan
 - Resume Medis Akhir
- l) Memperbolehkan Peserta pulang HANYA JIKA Peserta sudah menandatangani Surat Jaminan Akhir yang sudah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- m) Membebankan biaya kepada **PIHAK PERTAMA** hanya yang sesuai dengan kelas perawatan yang menjadi hak Peserta yang tercantum pada Kartu Peserta/ Jaminan Rawat Inap atau mengacu pada tarif yang telah disepakati.
- n) Menagih langsung jika terdapat kelebihan biaya (*excess charge*) atas pelayanan kesehatan kepada Peserta sebelum Peserta meninggalkan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- o) Menolak Peserta dalam hal-hal sebagai berikut:
- Peserta tidak dapat menunjukkan bukti Kepesertaan yang sah berupa Kartu Peserta yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** atau Bukti Diri yang lain, kecuali **PIHAK KEDUA** telah mendapatkan konfirmasi sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA** mengenai Kepesertaan Peserta.
 - PIHAK KEDUA** telah diinformasikan secara tertulis bahwa Peserta sudah dihentikan dalam atau dihentikan sementara.
 - Peserta meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa medis, dan/atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - Peserta berinisiatif meminta pelayanan kesehatan yang tidak perlu secara medis atau tidak berhubungan dengan perawatan yang harus dijalani, seperti tes laboratorium dan tes diagnostik.



- 5) Peserta meminta **pelayanan kesehatan** diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam Kartu Peserta atau Jaminan rawat inap.
- p) Segera mengirimkan tagihan biaya-biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**, dilengkapi dengan dokumen penagihan klaim paling lambat **30 (tiga puluh) hari kalender** setelah pasien pulang.
- q) Apabila perlu **PIHAK PERTAMA** dapat meminta keterangan medis mengenai Peserta kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan ijin dan kuasa dari Peserta untuk meminta dan atau menerima keterangan *Medical Record* Peserta, maka untuk maksud tersebut **PIHAK PERTAMA** akan bertanggung jawab penuh serta membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan hukum dari Peserta sehubungan dengan *Medical Record* yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- r) Menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa setiap Dokter yang praktek di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** telah memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih aktif/masih berlaku **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan salinan SIP Dokter yang memberikan pengobatan/perawatan pasien jika suatu saat diminta pada kasus tertentu, sebagai bukti pendukung dalam proses verifikasi tagihan dari **PIHAK KEDUA**. Apabila ditemukan dokter yang memberikan pengobatan/perawatan pasien ternyata SIP Dokter sudah kadaluarsa (*expired*), maka **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memproses tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
- s) Penggunaan kamar isolasi hanya digunakan untuk penyakit yang **benar-benar** butuh di isolasi (Penularan dengan udara), dan sesuai dengan indikasi medis lainnya masuk ke dalam kamar biasa.
- t) Menjaga integritas dengan tidak membuat dokumen palsu untuk digunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan dokumen palsu tersebut.

PASAL 5

TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN KESEHATAN

1. Dalam hal Peserta membutuhkan layanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib untuk terlebih dahulu memeriksa keabsahan kartu Peserta. Apabila diperlukan, **PIHAK KEDUA** dapat mengkonfirmasi Kepesertaan Peserta langsung kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** melalui telpon untuk mendapatkan Surat Jaminan Awal Rawat Inap.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan penolakan penjaminan rawat inap dan tidak membayarkan tagihan rawat inap dengan diagnosa rawat inap yang menurut **PIHAK PERTAMA** tidak kuat atau tidak sesuai dengan penyakit yang diderita Peserta. Biaya tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat ditagihkan ke Peserta.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak menetapkan batas manfaat biaya selama perawatan rawat inap, meliputi biaya terapi (obat-obatan), laboratorium, dan biaya pemeriksaan penunjang. **PIHAK KEDUA** wajib meminta persetujuan kepada **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu apabila biaya terapi/laboratorium/pemeriksaan penunjang mencapai atau melebihi Rp.1.000.000,- (*satu juta Rupiah*) untuk satu jenis tindakan atau obat-obatan atau pemeriksaan penunjang lainnya dengan disertai alasan medis yang kuat.
5. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mewajibkan Peserta untuk membayar uang muka dan/atau pembayaran apapun selama Peserta menjalani pengobatan/perawatan.
6. **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberi pertolongan dan perawatan terlebih dahulu pada

RECEIVED 10 10 1964

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: JAMES EARL RAY
RE: NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, OCTOBER 9, 1964.

Enclosed for the Bureau are two copies of a letterhead memorandum (LHM) dated and captioned as above. The LHM contains information regarding the activities of the subject in New York City during the period of his flight from the authorities.

The LHM is being prepared for the Bureau as a result of information received from a confidential source who has provided reliable information in the past.

It is requested that the Bureau advise this office of any further information received regarding the subject.

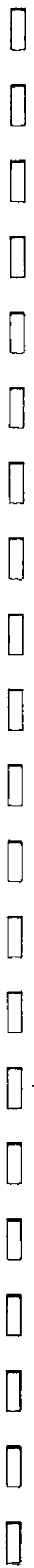
Very truly yours,
Special Agent in Charge

Enclosure

100-100000

Peserta dengan keadaan **gawat darurat** yang membutuhkan rawat inap, dan kemudian menghubungi **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 1 x 24 jam untuk mendapatkan jaminan rawat inap.

7. Pada keadaan **gawat darurat**, penyakit atau kecelakaan yang tiba-tiba dan serius, dan atau untuk kasus-kasus yang terjadi pada hari libur, maka layanan kesehatan dapat disediakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui **Unit Gawat Darurat**.
8. Peserta yang menurut indikasi medis perlu dirawat inap, dapat ditempatkan pada kelas kamar perawatan yang sesuai dengan hak kelas Peserta dan/atau tidak melebihi batas maksimum biaya kelas kamar yang tercantum dalam Kartu Peserta.
9. Dalam hal kelas kamar yang sesuai dengan hak Peserta penuh, maka **PIHAK KEDUA** harus melakukan konfirmasi ke Call Center 24 Jam Reliance Hotline atau Reliance Inpatient Monitoring (RIM).
10. Apabila Peserta meminta kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang tercantum dalam kartu Peserta, maka dijadikan pasien umum kecuali mendapat konfirmasi persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
11. **PIHAK PERTAMA** menjamin segala jenis golongan vitamin atau suplemen yang diresepkan oleh dokter dalam pelayanan rawat jalan untuk Peserta dan diperlukan secara medis, dengan ketentuan sbb :
 - a. Bertujuan untuk pengobatan bukan pencegahan.
 - b. Tidak berdiri sendiri dalam sekali pelayanan, sebagai terapi pendukung dari obat utama.
 - c. Tidak diresepkan bersamaan atau lebih dari satu golongan dalam sekali pelayanan.
 - d. Diberikan dalam jumlah yang wajar, mengikuti jumlah hari pemberian obat utama.
 - e. Tidak termasuk dalam produk MLM (Multi Level Marketing).
12. Untuk penyakit-penyakit tertentu (ibu hamil, fracture healing, anemia, hepatitis), dan lain-lain dapat diberikan vitamin atau suplemen sesuai dengan kebutuhan.
13. Pelaksanaan Layanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus tetap memperhatikan pengecualian-pengecualian sebagaimana disepakati oleh **para Pihak** yang tercantum dalam Lampiran perjanjian ini.
14. Segala jenis tindakan fisioterapi (biaya konsul dokter, terapi, dan obat-obatan) dimasukkan kedalam benefit fisioterapi.
15. Apabila ditemukan perbedaan informasi medis dari **PIHAK KEDUA** yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** akan menyebabkan tagihan **PIHAK KEDUA** tidak dibayarkan (menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**).
16. **PIHAK KEDUA** wajib dan memastikan serta menjunjung tinggi penerapan Pelayanan Kesehatan berdasarkan rencana perawatan sesuai dengan **Clinical Pathway**.
17. Penggantian biaya Layanan Kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** mengacu pada **Tarif** yang disepakati sebagaimana tercantum pada **Buku Tarif yang berlaku secara umum** telah disepakati bersama diantara **PARA PIHAK**. Dan bila terdapat pelayanan tidak sesuai dengan **Buku Tarif** yang berlaku, maka kami berhak menolak dan tidak dapat kami proses.
18. **PIHAK KEDUA** memberikan Layanan Kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** harus menghindari pelayanan berlebihan yang diberikan kepada peserta yang secara medis tidak diperlukan (**Over Treatment**).
19. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan biaya tambahan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk perawatan kasus **Cito**.



4
2

PASAL 6
BIAYA-BIAYA LAYANAN KESEHATAN

1. Penggantian biaya Layanan Kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** mengacu pada **Tarif** yang disepakati sebagaimana tercantum pada Lampiran Perjanjian ini, atau pada **Buku Tarif yang berlaku secara umum** telah disepakati bersama diantara **Para Pihak**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** ingin memberlakukan pembebanan biaya tambahan secara khusus yang tidak dan/atau belum tercantum didalam buku tarif kepada **PIHAK PERTAMA**, seperti *tambahan pembebanan biaya Administrasi Kerjasama Luar Kota, biaya pembuatan kartu dan lainnya* yang tidak berlaku pada umumnya harus disampaikan terlebih dahulu secara tertulis untuk disepakati bersama sebagaimana dimaksud didalam ayat 3 Pasal ini.
3. Setiap perubahan pada **Tarif** yang disepakati dan/atau **Buku tarif** harus diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan, dalam waktu paling lambat **30 (tiga puluh)** hari kerja sebelum pemberlakuan tarif baru tersebut. Tarif tersebut tidak berlaku surut.
4. Biaya administrasi rawat inap yang dibebankan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai master tarif.
5. Biaya administrasi rawat jalan yang dibebankan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.30.000- (*tiga puluh Ribu Rupiah*)
6. **PIHAK KEDUA** Setuju memberikan potongan harga (Diskon) sebesar **2% (Dua persen)** dari total biaya layanan kesehatan yang ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, baik tagihan rawat jalan maupun rawat inap. Adapun keterangan diskon dapat dicantumkan didalam Surat Pengantar Tagihan dan/atau Kuitansi Besar (invoice).
7. Apabila **Layanan Kesehatan** yang diberikan adalah berkenaan dengan pemberian obat kepada Peserta, maka para pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan tentang harga Jual Apotik atas harga obat yang diberikan kepada Peserta berdasarkan tatacara penghitungan sebagai berikut, maksimum :

$$\text{Harga Jual Apotik} = [(\text{HNA} + \text{PPN } 10\%) + 10\%]$$

Harga Netto Apotik (HNA) akan ditinjau dari waktu ke waktu oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan harga Distributor serta Jenis Obat yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** diutamakan adalah **Obat Generik, Daftar Obat Essential Nasional (DOEN)**.

8. Standar obat yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta **PIHAK PERTAMA** mengacu pada Standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

PASAL 7
TATACARA PENAGIHAN & PEMBAYARAN BIAYA

1. Tagihan dari **PIHAK KEDUA** harus sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja setelah pasien pulang**, jika melebihi batas waktu tersebut maka tagihan tersebut tidak dapat diproses.
2. Tagihan dari **PIHAK KEDUA** atas Layanan Kesehatan untuk Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** akan dibayarkan dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** untuk klaim rawat inap dan klaim rawat jalan, setelah diterimanya tagihan secara lengkap dari **PIHAK KEDUA**. Kecuali pada kasus dimana Peserta diperlakukan sebagai pasien umum, maka dokumen penagihan klaim akan diberikan pada Peserta untuk memudahkan penagihan klaim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika	Hal. 8/22	Paraf	Pihak I <i>[Signature]</i>
			Pihak II <i>[Signature]</i>



3. **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penagihan atas biaya layanan kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta harus sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam Kartu Peserta, jaminan rawat inap atau **Buku Tarif** yang telah disepakati, **PIHAK PERTAMA** hanya akan melakukan pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA** apabila sesuai dengan Dokumen-dokumen tersebut diatas.
4. Dalam hal pemberlakuan tarif baru, **PIHAK KEDUA** belum menyampaikan **Buku Tarif** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disepakati bersama, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membayar sesuai tarif yang sudah disepakati bersama oleh **para pihak (tarif lama)**.
5. **Dokumen penagihan klaim** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas adalah :
 - a. Formulir Pelayanan Medis
 - b. Kwitansi asli (bermaterai cukup), dan perincian biaya perawatan
 - c. Dokumen Pendukung sesuai dengan Layanan Kesehatan yang diberikan (bukti tindakan/ Penunjang Diagnostik)
 - d. Surat Rujukan
 - e. Salinan Resep
 - f. Salinan Ringkasan Catatan Medis
 - g. Mencantumkan nomor kartu Peserta di Formulir Pelayanan Medis/ Formulir Bukti Berobat
 - h. Rekap Klaim
 - i. Surat Jaminan
6. **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen tagihan yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila dokumen penagihan belum lengkap atau apabila **PIHAK PERTAMA** masih memerlukan dokumen tambahan maka **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi dokumen yang dimaksudkan guna memperlancar proses pembayaran ke **PIHAK KEDUA**.
7. Dalam hal dokumen penagihan belum lengkap, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut dan mengirimkannya ke **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari kerja. Apabila dokumen belum dilengkapi sampai jangka waktu tersebut maka tagihan tersebut **tidak dapat diproses**.
8. Pembayaran klaim-klaim akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan proses pemindah bukuan bank (bank transfer) ke :
 - **Nama Bank** : MANDIRI
 - **Cabang** : Sutoyo Malang
 - **No. Rekening** : 144-0055533324
 - **Atas Nama** : PT DISA PRIMA MEDIKA

Setiap perubahan rekening Bank harus diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (**tiga puluh**) hari kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.
9. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan pemberitahuan pembayaran ke bagian keuangan **PIHAK KEDUA** dengan fasilitas notifikasi email ke alamat email berikut :
 - PT Disa Prima Medika : disaprimamedika@gmail.com
 - RS Prima Husada Malang : keuangan@malang.rs-primahusada.com
 - RS Prima Husada Sukorejo : keuanganrsphs@gmail.com

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika	Hal. 9/22	Paraf	Pihak I <i>[Signature]</i>
			Pihak II <i>[Signature]</i>

THE
REPUBLIC
OF
THE
PHILIPPINES
OFFICE
OF
THE
COMMISSIONER
OF
LANDS
AND
MINES
MANILA

TO
HIS
HONORABLE
THE
GOVERNOR
OF
THE
ISLAND
OF
LUZON

IN
RESPONSE
TO
YOUR
LETTER
OF
THE
10TH
INSTANT

RE
YOUR
LETTER
OF
THE
10TH
INSTANT

AND
IN
RESPONSE
TO
YOUR
LETTER
OF
THE
10TH
INSTANT

AND
IN
RESPONSE
TO
YOUR
LETTER
OF
THE
10TH
INSTANT

AND
IN
RESPONSE
TO
YOUR
LETTER
OF
THE
10TH
INSTANT

AND
IN
RESPONSE
TO
YOUR
LETTER
OF
THE
10TH
INSTANT

AND
IN
RESPONSE
TO
YOUR
LETTER
OF
THE
10TH
INSTANT

AND
IN
RESPONSE
TO
YOUR
LETTER
OF
THE
10TH
INSTANT

AND
IN
RESPONSE
TO
YOUR
LETTER
OF
THE
10TH
INSTANT

PASAL 8
MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

1. Jangka waktu kerja sama pelayanan perawatan dan/atau pengobatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan evaluasi setiap tahun, terhitung sejak tanggal **06 November 2024** sampai dengan tanggal **06 November 2027**
2. Apabila tidak ada pemberitahuan dan konfirmasi dari **PARA PIHAK** mengenai pengakhiran kerjasama, maka perjanjian kerjasama akan diperpanjang secara otomatis
3. Pada saat perjanjian kerja sama ini berakhir tetapi masih terdapat pasien yang masih dalam perawatan dan atau pengobatan berdasarkan alasan-alasan medis yang ditentukan oleh dokter yang merawat harus tetap mendapat perawatan, pengobatan dan atau melanjutkan rawat inapnya, tetap akan mendapatkan haknya sampai sembuh dan akan diklasifikasikan sebagai kasus khusus yang tidak dapat terpengaruh dengan pemutusan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

1. Pemutusan hubungan kerja sama dapat dilakukan oleh salah satu pihak secara sepihak dengan memberitahukan maksudnya selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari kalender sebelumnya secara tertulis tanpa harus menerangkan dan meminta persetujuan atas alasannya seperti yang tertuang dalam isi perjanjian kerja sama ini.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan penyimpangan/penyalahgunaan terhadap ketentuan yang berlaku pada Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan kerjasama secara sepihak dan tidak membayarkan seluruh tagihan yang terjadi.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat kedua belah pihak sepakat memilih Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili tetap penyelesaian perselisihan.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam PKS ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya PKS ini oleh salah satu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan kedua belah pihak, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, pihak-pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat **7 (tujuh)** hari kalender setelah kejadian.
3. Apabila pihak yang mengalami *force majeure* lalai atau sengaja untuk tidak melaporkan kepada pihak lainnya akan kejadian *force majeure* yang menimpanya, maka pihak yang mengalami *force majeure* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan PKS ini

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi
Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika

Hal. 10/22

Paraf

Pihak I

Pihak II

[illegible]

sampai dengan tanggal pemberitahuan dari pihak yang mengalami *force majeure* kepada pihak lainnya.

4. Semua kerugian yang diderita satu pihak yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya, sebatas pihak yang terkena dampak daripada *force majeure* telah berusaha sebaik-baiknya untuk terhindar dari *force majeure* dan telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
5. *Force majeure* tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi pembayaran tersebut dapat ditunda, dengan ketentuan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan, denda, pengurangan hal atau pembebasan atas kewajiban.

PASAL 12 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga integritas, kredibilitas nama baik perusahaan dari masing-masing pihak dimana bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis (informasi tempelan) maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima dari salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:

1. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
2. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut;

1. PIHAK PERTAMA

PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA
Jl. Pluit Sakti Raya, No. 27 AB, RT.4/RW.6, Pluit, Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450
Telephone : (021) – 661 77 68
Fax : (021) – 66675075/ 77

Bagian : Provider Relation Department
Email : provider.health@reliance-insurance.com
UP : Yusnita
HP : 085176757692

Bagian : Rekonsil
Email : provider.rekonsil@reliance-insurance.com
provider.rekonsil2@reliance-insurance.com
UP : Lionis Indra/Riris
HP : 081297363770

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika	Hal. 11/22	Paraf	Pihak I <i>[Signature]</i> Pihak II <i>[Signature]</i>
--	------------	-------	--

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

TO: DR. J. H. GOLDSTEIN
FROM: DR. J. H. GOLDSTEIN

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

TO: DR. J. H. GOLDSTEIN
FROM: DR. J. H. GOLDSTEIN

RE: [illegible]

TO: DR. J. H. GOLDSTEIN
FROM: DR. J. H. GOLDSTEIN

RE: [illegible]

Bagian : Penjaminan/Admin Rawat Inap
 Email : rim@reliance-insurance.com ; hotline@reliance-insurance.com
 UP : RIM / Hotline
 Telp : 02180823177

2. PIHAK KEDUA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
 Telp. : (+62) 812 5299 885
 Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
 Telp. : 0341 - 458679

Bagian : Marketing/Humas
 Email : marketingrsphm@gmail.com
 UP : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
 HP : 0811 3507 164

Bagian : Keuangan/Piutang/Rekonsil
 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com
 UP : Novi Ratnasari, SE
 HP : (0341) 458679

Bagian : Penjaminan/Admin Rawat Inap
 Email : admklaim.rsph@gmail.com
 UP : Lilik Kurniati
 HP : 0813-3142-9720

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Jl. Raya Surabaya - Malang Km 54, Lemahbang, Sukorejo, Jawa Timur
 Telp. : 0343 - 458679

Bagian : Marketing/Humas
 Email : Backupdatamarketingphs@gmail.com
 UP : Lidia Emilinda S.Tr.Keb, MMRS
 HP : 081315574065

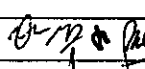
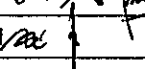
Bagian : Keuangan/Piutang/Rekonsil
 Email : keuanganrsphs@gmail.com
 UP : Anita Fitria Sari, S.E
 HP : 085156001411

Bagian : Penjaminan/Admin Rawat Inap
 Email : keuanganrsphs@gmail.com
 UP : Hanik Amalia, S.E
 HP : 082142036393

PASAL 14

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DAN PERUBAHAN

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan akan dicantumkan didalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika	Hal. 12/22	Paraf	Pihak I 
			Pihak II 

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO NOT

WARRANT
THE

OF

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

2. Kedua belah pihak sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani oleh yang mewakili masing-masing pihak, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.

PIHAK PERTAMA
PT Asuransi Reliance Indonesia

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA MEDIKA



Armon Trifery
Direktur

Suharjo P. Lumbanraja
Direktur



Endang Susilowati
Direktur

... ..

...

...

...

...

...

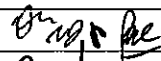
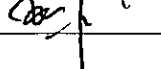
...

...

LAMPIRAN 1 **DAFTAR PENGECUALIAN**

Pelayanan kesehatan/tindakan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** :

- 1 Cedera atau penyakit yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung akibat:
 - a. Perang, segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan maupun tidak, mengemban tugas militer, keikutsertaan secara langsung dalam huru-hara, pemogokan dan pergolakan sipil atau pemberontakan, teroris.
 - b. Tindakan kriminal/tindakan melanggar hukum.
 - c. Usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan sendiri.
- 2 Produk yang dibeli secara bebas, atau tidak diperlukan secara medis termasuk : sabun mandi, tissue, pembalut, bedak, obat kumur, pasta gigi, sikat gigi, obat gosok (balsem, minyak angin), susu (terkecuali susu low lactosa untuk anak penderita diare yang di rawat inap), makanan bayi, tagihan telepon dan fax, laundry, obat-obatan yang dibeli diluar apotik serta vitamin dan food supplement yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan penyakitnya.
- 3 Pemberian resep obat penenang pada Rawat Jalan dengan diagnosa apapun
- 4 Biaya pembelian alat-alat bantu kecuali penyewaan alat tersebut selama perawatan-inap di Rumah Sakit.
- 5 Alat pacu jantung, Ring, Sten, Prothesa, Hearing Aid, dan organ tubuh pada tindakan transplantasi termasuk sumsum tulang.
- 6 Penyakit-penyakit di bawah ini serta segala akibat yang ditimbulkannya :
 - a. Penyakit menular seksual dan Penyakit yang timbul akibat Hubungan Sexual.
 - b. HIV-AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) & ARC (AIDS Related Complex).
 - c. Penyalahgunaan obat, penggunaan alkohol, narkotik, obat bius dan sejenisnya.
 - d. Disfungsi seksual, micro penis, Ejakulasi dini, Impotensi, Frigiditas.
 - e. Penyakit jiwa/penyakit mental lainnya, termasuk segala jenis Neurosis, Manifestasi dari gangguan kejiwaan atau Psikosomatis, segala jenis Psikosis, Gangguan Kepribadian.
 - f. Gangguan perkembangan seperti Gangguan wicara, Autisme.
 - g. Kontaminasi radioaktif.
 - h. Sirkumsisi (sunat) yang dilakukan pada Peserta yang berusia diatas 2 tahun atau yang dilakukan pada Peserta yang berusia sampai dengan 2 tahun tanpa indikasi medis, tindik, tattoo.
 - i. Hernia pada Peserta yang berusia sampai dengan 12 tahun.
- 7 Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan :
 - a. Kesuburan (infertilitas), segala pengujian dan perawatan kemandulan, dan usaha untuk mendapatkan keturunan antara lain: bayi tabung, hidrotubasi dan akibat-akibat yang ditimbulkan karena pengobatan-pengobatan tersebut diatas.
 - b. Kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan secara mekanis atau kimiawi, serta sterilisasi baik itu kastrasi, tubektomi dan vasektomi.
 - c. Terapi hormonal termasuk perawatan pra dan post menopause serta akibat-akibat yang ditimbulkan karena pengobatan-pengobatan tersebut diatas.
 - d. Gangguan hormonal dan gangguan menstruasi.
- 8 Istirahat untuk pemulihan atau perawatan di Sanatorium dan Rumah Sakit Khusus termasuk pengobatan untuk tujuan penyembuhan seperti lelah mental atau lelah fisik.

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika	Hal. 14/22	Paraf	Pihak I 
			Pihak II 



- 9 Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan penyakit menular yang diharuskan oleh hukum (pemerintah) untuk diisolasi/dikarantinakan dan wabah penyakit.
- 10 Setiap perawatan atau pembedahan terhadap kelainan bawaan/cacat kongenital (penyakit atau penyakit yang dibawa sejak lahir), hereditas (penyakit keturunan) antara lain: Atresia Ani, VSD, ASD, bibir sumbing, septum deviasi, cacat tulang, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thalassemia, haemophyllia.
- 11 Penyakit ayan (epilepsi).
- 12 Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan tujuan estetika termasuk operasi plastik atau bedah/perawatan kosmetik, perawatan khusus untuk pengurangan atau penambahan berat badan dan peningkatan tinggi badan, tindakan orthodontic.
- 13 Setiap pemeriksaan kesehatan atau fisik secara rutin/berkala, terapi fisik, Check-up kesehatan atau test-test yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa kondisi yang dijamin atau pemeriksaan yang tidak diperlukan secara medis termasuk Obstructive Sleep Apnea (OSA), Test dengan tujuan screening, obat-obatan atau pemeriksaan preventif termasuk semua jenis imunisasi-vaksinasi.
- 14 Perawatan atau Pengobatan yang bersifat Eksperimental serta pelayanan kesehatan yang belum diakui sebagai pengobatan medis standar di bidang kedokteran (DEPKES RI), antara lain: Pijat, dukun, ramuan tradisional, jamu, akupunktur oleh sinshu, akupresur, terapi ozon, terapi hyperbaric, Hydroterapi, chiropractic, Mesotherapy dan pengobatan lain yang sejenis.
- 15 Cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat dari keikutsertaan dalam aktifitas berbahaya antara lain: panjat tebing, panjat gedung, mendaki gunung, berburu, terjun payung, bungee jumping, terbang layang, kegiatan-kegiatan bawah air yang memerlukan perlengkapan bernapas, berkuda, olah raga bela diri, olah raga professional, perlombaan kecepatan dengan menggunakan kendaraan bermesin seperti mobil, motor, gokart, perahu, serta keikutsertaan pada penerbangan non komersil/tidak berjadwal.
- 16 Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Peserta atau oleh seseorang yang secara normal tinggal serumah dengan Peserta.
- 17 Biaya-biaya yang telah ditanggung Asuransi Tenaga Kerja, Organisasi Jaminan Sosial/JAMSOSTEK/ASKES atau perusahaan asuransi lain.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also provides a brief overview of the methodology used in the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It discusses the data sources, the data collection methods, and the data analysis methods. It also provides a brief overview of the results of the study.

3. The third part of the report is a detailed description of the results of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the findings. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

4. The fourth part of the report is a detailed description of the conclusions of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the findings. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

5. The fifth part of the report is a detailed description of the conclusions of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the findings. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

6. The sixth part of the report is a detailed description of the conclusions of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the findings. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

7. The seventh part of the report is a detailed description of the conclusions of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the findings. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

8. The eighth part of the report is a detailed description of the conclusions of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the findings. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

9. The ninth part of the report is a detailed description of the conclusions of the study. It discusses the findings of the study and the implications of the findings. It also provides a brief overview of the conclusions of the study.

RINGKASAN POLIS ARI - BIAYA NON MEDIS

No	Jenis biaya/alat-alat Non medis	Penjaminan
1	Sabun	tidak dijamin, contoh : Lactacyd Baby, Sebamed
2	Tissue	tidak dijamin
3	Pembalut	tidak dijamin
4	Bedak	tidak dijamin, contoh : Salicyl Talc, Herocyn, Caladine
5	Cream/Gel	dijamin , contoh : Counterpain Piroxicam (Pxm), Voltaren Gel, Infeld Gel, Kaltrofen Gel, Pirofel Gel, Rhetoflam, Scantaren Gel, Valto Gel tidak dijamin , contoh : Counterpain, Lafalos, Joint Fit Roller Gel, Vicks Vaporub, Transpulmin Balm
6	Obat Penenang	tidak dijamin : contoh : Zypraz, Frisium, Carbamazepine, Halloperidol, Trihexyphenidyl, Alganax, Valisanbe, Xanax
7	Obat Hormonal	tidak dijamin, contoh : Primolut, Profertil, Dismeno
8	Obat Herbal	tidak dijamin, contoh : Pujimin, Vermint
9	Obat Estetik	tidak dijamin, contoh : Dermatix, Mederma, Carmed, Tracne, Isotretinoin, Vitacid, Lanakeloid, Moisderm
10	Obat kumur	dijamin , contoh : Alocclair, Sanorine, Hexadol, Forinfec, Molexdine, Scansepta, Fordenta tidak dijamin , contoh : Listerine, Minosep, Enkasari
11	Pasta gigi	tidak dijamin
12	Obat gosok (balsem, minyak angin)	tidak dijamin
13	Susu	tidak dijamin (terkecuali susu low lactosa untuk anak penderita rawat inap maksimal satu kemasan kaleng/kardus)
14	Makanan bayi	tidak dijamin
15	Alat Bantu	Tidak dijamin, contoh Elastic Verband (Tensocrepe, Policrepe), Armsling, Korset, Collar Neck, Kursi Roda, Tongkat, Knee Brace
16	Tagihan telpon dan fax	tidak dijamin
17	Laundry	tidak dijamin
18	Obat-obatan yang dibeli diluar apotik	tidak dijamin
19	Kartu penunggu	tidak dijamin
20	Buku kesehatan	tidak dijamin
21	Buku bayi	tidak dijamin
22	Surat keterangan lahir	tidak dijamin
23	Kartu/embos	tidak dijamin
24	CD hasil test diagnostik	CD tdk dijamin
25	Gelang pasien	tidak dijamin
26	Termometer	tidak dijamin



RINGKASAN POLIS ARI - BIAYA NON MEDIS

No	Jenis biaya/alat-alat Non medis	Penjaminan
27	Kotak obat	tidak dijamin
28	Medicine cup/mangkuk obat	tidak dijamin
29	Susu Bayi (bayi baru lahir)	tidak dijamin
30	Gibs	dijamin
31	Armsling	tidak dijamin
32	Pisau cukur/Silet	tidak dijamin
33	Cotton bud	tidak dijamin
34	Makanan utk penunggu	tidak dijamin
35	Pampers	tidak dijamin
36	handuk , hand towel	tidak dijamin
37	Extra bed	tidak dijamin
38	Salon	tidak dijamin
39	Masker Nebulizer	dijamin
40	Tensocrepe	tidak dijamin
41	Bed liner	tidak dijamin
42	Makanan tambahan, air mineral	tidak dijamin
43	Kendil	tidak dijamin
44	Gurita	tidak dijamin
45	Breast pump	tidak dijamin
46	Bedong bayi	tidak dijamin
47	Tindik	tidak dijamin
48	Botol susu	tidak dijamin
49	Waslap	tidak dijamin
50	Paket pasien (perlengkapan mandi)	tidak dijamin
51	Maternity Napkin	tidak dijamin
52	Underpads	tidak dijamin
	Khusus Maternity	
53	Vaksinasi bayi	dijamin dlm manfaat imunisasi
54	Jasa penyuntikan Vaksin	dijamin dlm manfaat imunisasi
55	Screening Bayi	tidak dijamin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Pihak I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Pihak II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KARTU PESERTA "SHOW CARD" INDEMNITY PYRAMID

Tampilkan Depan

No. Kartu : 88013700601000041
No. ID Peserta : 000004-1
Nama Peserta : WENDI
Tanggal Lahir : 07 Desember 1994
Jenis Kelamin : Pria
Perusahaan : PT. INTEGRITAS SOLUSI MEDIKA
Berlaku s.d. : 15 September 2021

your reliable partner

Perhatian: Pastikan kartu ini disertai menunjukkan kartu service yang ada.
Nama unit peserta yang tercantum di atas kartu.

Tampilkan Belakang



Catatan :

1. Kartu berlogo IsoMedik diterima jika RS sudah memiliki Web IsoApps
2. RS harus jaringan Reliance- ISOmedik
3. Peserta Wajib Rujukan sebelum ke RS

Kartu Elektronik (E-Card)

ReliHIT

Reliance
Insurance

Nama Peserta : SILVI
No. ID Peserta : 000007-1
NIP :
Tgl Lahir : 03 Aug 90
Jenis Kelamin : F
Perusahaan : DUMMY POLIS
Nomor Polis : HJK20221010000300
Berlaku sampai : 31 Dec 21

your reliable partner

Perhatian: Pastikan kartu ini disertai menunjukkan kartu service yang ada.
Nama unit peserta yang tercantum di atas kartu.

Kelas Kamar : Rp 1,000,000.00

R. INAP	R. JALAN	R. BERSALIN	R. GIGI
-	-	-	-
PRE-POST BERSALIN	IMUNISASI	KB	
-	-	-	

Tanda Tangan Peserta

FM.UW.02.09-00

TOLL-FREE HOTLINE:
0800-100-0327

PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA

Reliance Capital Building, Jl. Pluit Sakti Raya No. 27AB, Jakarta Utara 14450
Tlp. 021 2266 7005, 021 8082 3177 (Hotline 24/7) Fax 021 2922 2928

1. Jika sudah menunjukkan E-Card ini peserta tidak perlu menunjukkan kartu fisik.
2. RS Tidak perlu mencetak atau Copy E-Card untuk dokumen penagihan.
3. RS Wajib mengisi Formulir claim (lampiran 4) Secara lengkap jika peserta menggunakan E-Card

LAMPIRAN 3 SURAT JAMINAN

Reliance
Insurance

PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA
Menara Batavia Lantai Dasar
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220

RELIANCE IN-PATIENT
MONITORING
+62 21 57902800
RELIANCE HOTLINE 24/7
+62 21 57930328



SURAT JAMINAN	
No. Jaminan :	Acc By :

Jakarta,

Kepada Yth,

No. Telp :
No. Fax :
Up :

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini, selaku penanggung jawab biaya dalam program Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Reliance Indonesia, menyatakan bahwa Peserta / Tertanggung :

Nama Peserta :
No. Peserta :
Nama Karyawan :
Tanggal Lahir Peserta :
Jenis Kelamin Peserta :
Nama Perusahaan / No. Polis :
Plafon Kamar : , apabila tidak tersedia dapat menempati maksimum Kamar Rp. /ICU

Adalah benar Peserta Asuransi kesehatan PT. Asuransi Reliance Indonesia , dengan status kepesertaan yang masih aktif dan saat ini sedang membutuhkan perawatan / pelayanan medis :

Coverage :
Tanggal masuk :
Diagnosa :
Menempati Kelas Kamar :

Dan menginformasikan bahwa Asuransi Reliance Indonesia dapat memberikan jaminan untuk pelayanan kepada pasien sesuai data yang tersebut diatas

Catatan :

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,
PT. Asuransi Reliance Indonesia

Departemen RIM

Disiapkan oleh :

Perhatian untuk Provider :

Surat Jaminan ini berlaku, apabila dilampirkan oleh surat pernyataan pasien yang telah diisi lengkap.

1. Penjaminan Rawat Inap untuk hari
2. Bila Diagnosa akhir termasuk pengecualian polis maka penjaminan batal
3. Biaya obat-obatan atau tindakan dengan harga satuan diatas Rp. 500.000,- harap dikonfirmasi ke +62 21 57902800
4. Mohon dikirimkan kembali setelah ditandatangani oleh peserta ke fax +62 21 29222928 / +62 21 57930328 atau email ke rim@reliance-insurance.com
5. Berkas dilampirkan saat pengiriman untuk proses klaim.
6. Surat jaminan ini di cetak secara otomatis, tanda tangan petugas tidak diperlukan.

FM-PLR-02-02-01 02 MARET 2015

Report Name : rpt_CSM_jaminan.rpt

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi
Asuransi Kesehatan dengan PT Disa Prima Medika

Hal. 20/22

Paraf

Pihak I *[Signature]*
Pihak II *[Signature]*

SURAT JAMINAN
JAMINAN 2

Kotak 1

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

LAMPIRAN 4 FORMULIR PERAWATAN

Reliance
Insurance

PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA
Jl. Pluit Kencana Raya No. 37
Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara

RELIANCE HOTLINE 24/7
+ 62 21 8082 1177 ext. 1
RELIANCE IN PATIENT
MONITORING
+ 62 21 8082 1177 ext. 2



FORMULIR KLAIM ASURANSI KESEHATAN HEALTH INSURANCE CLAIM FORM

Formulir klaim ini harus diisi lengkap, ditandatangani oleh Peserta atau Pemegang Polis yang berhak dan diterima oleh PT Asuransi Reliance Indonesia sebelum 30(tiga puluh) hari setelah tanggal perawatan/pelayanan kesehatan. Lengkapi Formulir Klaim dengan data sebenarnya, ditandatangani oleh dokter yang merawat dan keterangan nomor SIP dokter, serta lampirkan kuitansi pembayaran asli, salinan hasil laboratorium, test diagnostik, rontgens, resume medis dan lain-lain yang berkaitan dengan perawatan termasuk didalamnya copy resep, yang lengkap dengan alamat dan nomor telepon rumah sakit/ klinik, dan cap rumah sakit/ klinik.

Formulir Klaim yang tidak lengkap tidak dapat diproses. Untuk Klaim Rawat Inap, lampirkan copy hasil resume medis (medical record) dari rumah sakit/ klinik/Puskesmas.

This Claim Form must be completed in full, signed by the eligible member of Policy Holder and received by PT Asuransi Reliance Indonesia within 30(thirty) days after the date of services. Please complete this Claim Form with actual data, signed by attending physician, completed with physician SIP number, and attached with original payment receipt, copies of the laboratory results, diagnostic test, x-rays, medical resume and others relating to the treatment including a copy of the prescription, with hospital/clinic's address and phone number and stamped by hospital/clinic.

Uncomplete Claim Form can not be processed. For Inpatient Claim, please attach copies of the medical resume (medical record) from hospital/clinic/ public health center.

INFORMASI PASIEN diisi oleh Peserta to be filled by member **PATIENT INFORMATION**

Nama Perusahaan Company Name		Nomor Polis Policy Number
Nama Peserta Patient Name	Nama Karyawan Employee Name	Nomor Peserta Membership Number
Tanggal Lahir Date of Birth dd/mm/yy	Jenis Kelamin Gender ☐ Pria Male ☐ Wanita Female	Hubungan Relationship ☐ Istri Wife ☐ Suami Husband ☐ Anak Child

INFORMASI PELAYANAN SERVICE INFORMATION

Jenis Pelayanan Service Type ☐ Rawat Inap Hospitalization ☐ Rawat Pra/Pasca Melahirkan Pre/Post Maternity ☐ Rawat Pra/Pasca Rawat Inap Pre/Post Hospitalization ☐ Dokter Umum General Practitioner ☐ Melahirkan Maternity ☐ Dokter Spesialis Specialist Doctor ☐ Dokter Gigi Dentist		Nama Rumah Sakit/Klinik Hospital/Clinic Name
		Tanggal Masuk Date of Admission
		Tanggal Keluar Date of Discharge

KETERANGAN DOKTER diisi oleh Dokter yang merawat to be filled by attending physician **PHYSICIAN INFORMATION**

Anamnesa Anamnesis	
Pemeriksaan Fisik & Penunjang Medis Physical Examination & Supporting Diagnostic Examination	
Tindakan/Terapi Procedure/Medication	
Diagnosa Masuk First Diagnosis	Diagnosa Keluar Final Diagnosis
Apakah diagnosa penyakit tersebut berhubungan dengan: Is the diagnosis related to: ☐ Kesuburan/Ketidaksuahan Fertility/Infertility ☐ Hormonal Hormonal ☐ Kosmetika Cosmetic ☐ Kehamilan Maternity ☐ Kelainan Bawaan/Keturunan Congenital/Hereditary ☐ Kejiwaan/Psikosomatis Psychiatric/psychosomatic ☐ Penyakit menular seksual Sexually transmitted disease ☐ Tidak termasuk semuanya Others	

PERNYATAAN PEMBERIAN KUASA AUTHORIZATION

Dengan ini saya memberi kuasa kepada PT. Asuransi Reliance Indonesia untuk mendapatkan data medis maupun riwayat kesehatan saya dari rumah sakit/klinik/dokter sejauh diperlukan untuk menilai klaim ini. Saya juga memberi kuasa kepada PT. Asuransi Reliance Indonesia, untuk menginformasikan rincian klaim atau perawatan kepada perusahaan tempat saya bekerja, jika perawatan yang saya terima merupakan bagian dari manfaat Program Kesehatan Karyawan; dan kepada perusahaan Asuransi, jika klaim ini termasuk manfaat yang dijamin polis Asuransi. Jika batas pengobatan melebihi batas manfaat yang saya miliki, maka saya bersedia membayar kelebihan biaya yang terjadi. PT Asuransi Reliance Indonesia tidak menjamin obat yang mempunyai efek penenang, vitamin tunggal atau vitamin sejenis lebih dari satu, produk yang dibeli secara bebas atau tidak diperlukan secara medis seperti: sabun, shampoo, balsam, dll serta obat kosmetik. Ditandatangani di Signed at Tanggal Date dd/mm/yy Tanda tangan Pasien/Wali/Orang tua Pasien Patient/Ward/Parent signature	I hereby authorize PT. Asuransi Reliance Indonesia to get my medical data or my medical record needed to analyze my claim from health provider/hospital/physician. And I also authorize PT. Asuransi Reliance Indonesia to inform the claim or medical care to my working place, if the medical care I have received is a part of employees health program benefit, and to insurance company, if the claim is included in benefit that was covered by insurance policy. If the treatment cost over my benefit limit, I will pay the excess of the benefit. PT. Asuransi Reliance Indonesia shall not guarantee drugs that have side effect as sedative, stand alone vitamin and more than one vitamin that have same purpose, products which are bought over the counter or which are not medically required such as: soap, shampoo, balm, etc. and cosmetics's medicine. Tanda tangan, Nama dan SIP Dokter yang merawat Attending Physician's Signature, Name, and SIP Number
---	---

FM.CL.01-01 120801

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi
Asuransi Kesehatan dengan RS

Hal. 21/22

Paraf

Pihak I

Pihak II

17 1/2

LAMPIRAN 5

**Surat Larangan Pemberian Suap dan Gratifikasi kepada Karyawan
PT. Asuransi Reliance Indonesia**

Dengan hormat,

Salam hangat kami sampaikan, semoga aktifitas yang kita jalankan selalu berjalan dengan lancar dan sukses, serta terima kasih kepada Bapak/Ibu atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini.

Sebagai upaya penerapan Good Corporate Governance terutama prinsip-prinsip transparansi dan independensi di Perusahaan kami, melalui surat ini kami ingin menegaskan kembali kode etik kami, bahwa PT. Asuransi Reliance Indonesia melarang setiap karyawannya untuk menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra maupun rekanan kami. Kami telah dan akan selalu melakukan tindakan tegas terhadap karyawan kami yang melanggar kode etik tersebut. Hal ini kami lakukan guna memastikan bahwa profesionalisme dan nilai-nilai luhur budi pekerti di Perusahaan kami tetap dijunjung tinggi.

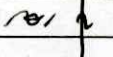
Untuk selanjutnya, kami akan sangat berterima kasih apabila pihak Bapak/Ibu dapat memberitahukan kepada kami jika menemukan indikasi terjadinya pelanggaran atas kode etik tersebut, melalui email: quality.assurance@reliance-insurance.com. Kerahasiaan dari informasi tersebut akan kami jaga demi kepentingan bersama. Mohon surat ini dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait dari Bapak/Ibu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,


PT Asuransi Reliance Indonesia®

Armon Trifery
Direktur

Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Reliance Indonesia Divisi Asuransi Kesehatan dengan RS	Hal. 22/22	Paraf	Pihak I 
			Pihak II 

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY

OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.